PRECONCEPTION / PERSONAL PLAN

你们的备孕行动手册

深圳 · 2026.11 至验孕后早期随访 · 个性化版本 1.0

期待在 2027 年 9 月中旬至 11 月相见

为一对希望自然、轻松备孕的伴侣制定。出生月份是偏好：可以接受提前或推后，未孕则继续尝试。计划以目前提供的真实信息为基础，不要求把生活变成检测任务。

先记住这四件事

女方每天继续 0.4 毫克叶酸；把“饿了再吃”改为规律三餐加餐；11 月核对疫苗与口腔情况；预计 12 月中下旬来月经的周期开始正式尝试。

准备期	主要尝试期	如果暂未怀孕
现在至 12 月中旬	约 2026 年 12 月下旬至 2027 年 3 月	继续自然尝试，按实际周期更新
续领叶酸、规律吃饭、散步、疫苗核对	每 2-3 天一次同房；试纸可选	不把错过出生月份理解成备孕失败

如何使用这份手册

先读第 01-04 节决定什么时候、怎样尝试；第 05-13 节用于处理验孕、补充剂、饮食、运动和就医；第 14-15 节可以打印记录、带去门诊。末尾列出可点击的参考来源。

日期按香港／深圳时间。编制与资料核对日期：2026 年 11 月 6 日。本文是健康教育与日程建议，不代替体格检查、诊断或处方；如接种补种或发现新病史，先更新计划。

01 / 你们现在的起点

已有准备很充分；下一步聚焦营养、时间和少量信息核对

项目	已知情况	在计划中的意义
女方	现年 27 岁；160 厘米、44 公斤；BMI 17.2	长期体重稳定但偏瘦；先改善摄入，无须快速增重
男方	现年 26 岁；170 厘米、72 公斤；BMI 24.9	按中国成人常用标准属于超重范围；以活动和饮食结构调整为主
月经	约 29-33 天；出血约 5 天；首日较多、轻度痛经	总体较规律；没有已知必须先做连续排卵监测的理由
既往妊娠	双方均无已知妊娠经历；尚未开始正式尝试	过去避孕期间未孕，不能据此诊断不孕
检查与接种	2026 年 5 月免费孕检；医生未提示其他异常；9 月底补乙肝疫苗	记录原结论；尽量调取原报告，按需核实而非重做整套
生活方式	不吸烟；无明确职业暴露；男方每月约 3-4 次、每次一罐啤酒	保持无烟环境；运动、规律饮食是可改进项
叶酸／鱼油	女方 8 月中旬起叶酸每日一片；鱼油每日一粒	叶酸确认 0.4 毫克；鱼油须另看适用人群

哪些内容还不能从现有信息推断

免费孕检未提示异常，并不等于已确认风疹／水痘免疫、每项地贫结果或双方所有生育功能正常。报告已删，先联系原检查机构查阅病历或电子结果；不把未知写成阴性。女方具体睡眠时长、每日膳食量尚未量化，先按本计划观察两周。

有关八年的避孕史

避孕套和体外射精期间未孕，不等于八年规律备孕未孕。体外射精仍可能怀孕：如果过去其实有长期、频繁的无保护阴道性交，请在门诊如实说明；医生会综合这段经历判断是否需要提早评估。

女方 2027 年 1 月满 28 岁，男方 2026 年 12 月底满 27 岁。仅据年龄和现有病史，不需要因生日变化升级为高龄备孕方案。

依据：[1][2][3]；个人资料来自双方自述，非病历核验。

02 / 出生目标与尝试日历

先选周期，再随着每一次实际月经重算

目标出生区间：2027 年 9 月 15 日至 11 月 30 日。按“受精日加 266 天”倒推，让预产期落在此区间的受精日期约为 2026 年 12 月 23 日至 2027 年 3 月 9 日。这是预产期区间，不是能保证出生日期的受孕边界。

原始月经首日：2026 年 4/15、5/15、6/15、7/17、8/15、9/15、10/18。相邻间隔依次为 30、31、32、29、31、33 天。

六个间隔平均 31 天；最近两次第一天最可靠，较早记录为回忆值。下面采用每次均 31 天的单一示例，排卵示例日取月经首日后约 17 天，预产期取该日后 266 天。自然排卵可偏移，日期会逐月累积误差。

假设月经首日	加密同房示例 周期第 10-22 天	排卵／预产期示例	安排
2026/11/18	11/27-12/09	12/05 → 2027/08/28	准备期，继续避孕
2026/12/19	12/28-2027/01/09	01/05 → 2027/09/28	首次正式尝试
2027/01/19	01/28-02/09	02/05 → 2027/10/29	继续尝试
2027/02/19	02/28-03/12	03/08 → 2027/11/29	继续尝试，接受跨至 12 月
2027/03/22	03/31-04/12	04/08 → 2027/12/30	未孕则按你们意愿继续

每次实际月经一来，就覆盖旧预测

第 1 天 = 正常月经出血第一天，少量褐色点滴另记。周期第 N 天 = 实际首日 + N−1 天。11 月 App 预测 17 日、均值示例 18 日的差异不重要；以实际出血为准。第 10-22 天是宽覆盖安排，并非每天都“易孕”，其他日期也不能当安全期。

时间余量：以孕 37-42 周作演示，9/28 预产期可对应约 9/7-10/12 分娩，11/29 则可对应约 11/8-12/13；这不是全部可能范围。2 月受孕、10 月下旬预产期距离两端更远，但不建议只押一个周期。

不为卡月份自行促排、引产或提前分娩。即使排卵日明确，分娩仍有变异；孕早期超声可进一步校正预产期。

依据：[4][5]；表内日历为个性化算例，不是排卵检测结果。

03 / 从现在开始，按月做什么

优先执行少而稳定的行动

时间	女方重点	男方／共同重点
11 月上中旬	叶酸继续；暂停当前非孕期专用鱼油；开始三餐 + 1-2 次加餐；每周称重一次	一起散步；男方开始减少久坐；查找五月孕检记录、九月疫苗记录
11 月内	口腔检查，发现蛀牙及时处理；社康咨询偏瘦营养与风疹／水痘免疫证据	有记录先用记录；没记录由医生决定是否测针对性 IgG、是否补种
11 月实际月经	准确记下首日、持续天数、经量与疼痛；无需天天测体温	正式尝试前每次全程使用避孕套，不依赖体外射精或 App 安全期
12 月上中旬	检查叶酸库存；回看 2-4 周体重与饮食；若有活疫苗补种，确认等待期已满	准备 2 支早孕试纸；排卵试纸可不买；安排共同采购和做饭
12 月中下旬起的实际周期	满足疫苗等待要求、无新医疗限制后进入正式尝试	每 2-3 天一次；都愿意时第 10-22 天可隔天一次
2027 年 1-3 月	按实际月经更新；到预计月经日再验孕；阴性按规则复测	不以单个周期结果评价任何一方；每月只复盘一次
3 月以后如未孕	继续叶酸与自然尝试，保留实际月经记录	继续尝试；需要安心或有疑问可预约咨询，无须等满一年才允许求助

每周十分钟复盘

- ☐ 这周叶酸是否持续？库存是否至少还够一个月？
- ☐ 女方是否大多数天吃齐三餐，且有一次营养加餐？
- ☐ 女方体重是否稳定或缓慢上升？是否出现体重下降、明显乏力？
- ☐ 两人是否散步至少 5 天？男方是否有起身活动？
- ☐ 是否出现新药、接种或不适，需要改日程？
- ☐ 同房安排是否舒适？有压力时回到每 2-3 天一次即可。

如水痘需要完整补种，可能涉及两针及末针后的等待期，原定首次尝试需顺延。优先完成必要准备，不为了守住某个月份缩短接种间隔。

依据：[5][6][7]；月份任务与每周清单为个性化执行建议。

04 / 轻松尝试：你们的默认方案

主方案不用监测；试纸只是选择，不是任务

方案 A：先用这个

从正式尝试周期起，整个周期在双方舒适、自愿的前提下，每 2-3 天一次不避孕阴道性交，并让精液进入阴道。月经期不舒服可以暂停。不要等 App 某一天才第一次尝试，也不需要精确到早上或晚上。

如果愿意稍微增加覆盖，实际月经第 10-22 天隔天一次即可，其余时间维持舒适节奏。这个宽范围是为 29-33 天的周期留余量，不意味着已确认排卵。错过一天不必“补交任务”，按正常节奏继续。

一个例子，不是必须打卡的日历

若月经实际从 12 月 19 日开始，第 10 天是 12 月 28 日。可在 12/28、12/30、1/1、1/3、1/5、1/7、1/9 中按精力安排；若全周期本来已每 2-3 天一次，就不用额外加任务。

方案 B：想了解排卵时，选 1-2 个周期试用

- ☐ 月经第 10 天左右开始，每天按同一产品说明书测一次；普通条带与数字型产品的取样时段可能不同，晨尿要求以说明书为准。
- ☐ 检测前避免短时间大量饮水，按规定时间读结果；普通条带一般要检测线达到或深于对照线才算阳性，浅浅第二条并不等同阳性。
- ☐ 第一次明确阳性当天和次日可安排同房；此前仍按每 2-3 天一次覆盖，不需要等到“最深”才开始。
- ☐ LH 阳性提示可能临近排卵，不能证明卵子已排出，也不是怀孕试纸。没有测到峰值时，可能漏测或延迟，先继续正常频率。
- ☐ 连续 2-3 个周期一直测不到阳性、反复多日阳性或月经变得不规律，可带记录咨询妇科；不凭试纸自行用药。

你们可以省掉的步骤

不要求每天基础体温、连续医院 B 超或“养精”禁欲一周。自然流出的部分精液很常见；没有证据要求特定体位、抬腿或长时间平躺。不冲洗阴道；如需要润滑，选择标注适合备孕／精子相容的产品，避免因此疼痛或勉强同房。

依据：[5][6][8][9]。具体周期安排是建议，可根据感受减量。

05 / 验孕、阳性与最初几周

先等合适时间，再用结果指导下一步

情况	怎么做
预计月经日到了还没来	用尿早孕试纸，按说明书取样、在规定时限内读结果；早期使用晨尿更便于减少尿液稀释的影响
阴性，月经仍没来	过 2-3 天再测；若仍阴性且超过平常周期约一周，预约社康或妇科
完全不知道下次月经何时来	某次无保护同房后至少 21 天可检测；若持续同房，阴性只能解释此前足够久的暴露，仍可能有更新的妊娠
规定读数时间内出现淡淡阳性	按可能怀孕处理，联系门诊确认；超过读数时限才出现的印迹不用于判定
有腹痛、出血或晕厥	不等待试纸加深或下一次复测；按第 13 节分级就医

阳性后的第一周

- ☐ 继续每日 0.4 毫克叶酸，避免酒精和烟草；先停当前降血脂用途鱼油，带标签核对补充剂。
- ☐ 记录末次正常月经第一天、首次阳性日期；预约社康／妇幼或产科早孕门诊，说明这是首次怀孕。
- ☐ 告诉医生此前孕检、乙肝补种、体重和全部用药；不自行停必要处方药，也不自行服“保胎药”。
- ☐ 无症状时按门诊安排做首次超声，常在末次月经起约 6-8 周评估；太早检查可能暂时看不到，需结合排卵偏晚的可能性复查。
- ☐ 有宫外孕疑似症状、出血或其他风险时提前评估，不等到预约孕周。

深圳的后续衔接

阳性后即可咨询建册与产检预约，争取孕早期完成首次系统评估；不要等到肚子明显变大。深圳公开产检范围列有 13 周前建立母子保健手册，具体流程、医保资格和项目以就诊机构当时要求为准。

避免被线条深浅牵着走

尿试纸颜色不能可靠判断胚胎健康、是否宫内孕或是否需要保胎。是否抽血测 HCG／孕酮、是否复查及间隔，由症状和临床问题决定；不常规自己每天查血、套用“必须翻倍”的单一规则。

依据：[10][11][12]；无症状早孕预约时机为一般流程建议，医生可调整。

06 / 补充剂：哪些继续，哪些先停

依据你们提供的实际标签，而不是凭品牌作保证

产品／事项	已确认与未确认	你们怎么执行
社康叶酸片	图片明确每片 0.4 毫克；女方每日一片，自 8 月中旬持续	每天继续一片；餐前后均可，选容易记住的时间；吃完续领
Member’s Mark 鱼油	正面每粒 EPA 475 毫克、DHA 190 毫克，合计 665 毫克；标注“辅助降血脂”	女方无已知降血脂治疗需求，建议先暂停这款；不作为孕期 DHA 默认方案
鱼油的限制	未见实物完整背标，不能确认辅料、维生素 A 或适用／不适宜人群	查背标；如列孕妇、乳母不适宜，正式尝试和孕期不用；需要时交药师核验
之前服过的维生素 C	剂量与用时不详；没有已知缺乏指征	常规饮食足够时无需额外高剂量补充；既往一般剂量服用通常不要求推迟受孕
复合孕期维生素	目前未报告使用	不必为备孕堆产品；若以后换用，核算其中叶酸并避免重复、额外加量

为什么对这款鱼油更谨慎

中国鱼油保健食品原料目录列有孕妇、乳母等不适宜人群；这不等于所有食用鱼或所有孕期 DHA 都有问题，也不能替代对这瓶背标的确认。你们现阶段没有必要为了补 DHA 继续一款以降血脂为用途的产品。此前吃过本身不说明已造成伤害，不需要“排毒”，也没有因此固定延迟数月的依据。

如果平时很少吃鱼

优先每周吃 2-3 次充分煮熟的低汞鱼虾，含一次三文鱼等富脂鱼。孕期若膳食不能满足，可与医生或药师讨论适用孕期、无额外视黄醇的 DHA 产品，例如每天约 200 毫克 DHA 的补充方案；不是所有人都必须另买，也不需拿高 EPA 产品凑量。

叶酸的三个细节

漏服一次：想起时按说明书处理，临近下次则跳过，不自行加倍。0.4 毫克 = 400 微克，不是 4 毫克。至少继续至孕 12 周；孕中晚期可按产科营养方案继续，不自行叠加多种叶酸。

当前自述无高危病史，没有自行升至高剂量叶酸的依据。铁、钙、维生素 D、锌、辅酶 Q10 或男性“助孕”保健品均按饮食、病史与必要化验决定，不作为整套必买清单。

依据：[7][13][14][15][16]；图片只确认可见标签，不作为真伪或质量鉴定。

07 / 女方营养：让身体有稳定的供给

长期偏瘦，也值得在孕前做一次营养评估

44÷1.60² = BMI 17.2。47.4 公斤约对应 BMI 18.5，仅是参考下限，不是受孕许可证。长期稳定、周期规律是有用信息，但不能单凭它排除摄入不足。现在开始改善，尝试前争取有规律吃饭和缓慢上升的趋势；不要求六周内必须增到某个数字。

第一步：从“饿了才吃”改为可预测的进餐

时段示例	女方具体做法
起床后 1-2 小时内	早餐含主食 + 蛋／奶或豆制品；不要只有一杯饮料
午餐、晚餐	每餐有米饭／面／薯类、肉鱼蛋豆类及蔬菜；不以汤或水果代替正餐
上午或下午加餐	选牛奶／酸奶 + 面包，或坚果 + 水果；按胃口分为 1-2 次
运动后或晚间饥饿时	补一份奶、面包或其他正常食物，不因“晚上不能吃”硬扛饥饿

第二步：先额外增加约 300 千卡／天

在原有饮食上加一份约 300 千卡的营养加餐，例如全脂牛奶约 250 毫升 + 一片面包 + 少量坚果，实际热量以标签为准。适应后可由营养师结合体重趋势调至额外约 300-500 千卡；这是增重起始方法，不是已测算好的每日总热量处方。

每周同一天起床排尿后、早餐前称一次即可。最初可争取平均每周约 0.1-0.25 公斤的缓慢趋势，短期水分波动不算失败。2-4 周无变化，先检查是否真的增加了摄入，再请社康／营养门诊个体化调整。

何时需要排查偏瘦原因

若不明原因持续下降、腹泻、心慌手抖、明显乏力或月经拉长，及时就诊；医生再决定血常规、铁蛋白、甲状腺、消化吸收等检查。不因为偏瘦直接诊断甲亢，也不盲目吃铁剂。

怀孕后要换一种管理方式

阳性后不再按“孕前增重速度”自行加码，带上孕前 44 公斤及近期记录，由产科按单胎／多胎、实际孕周和营养状况建立孕期增重目标。孕早期不需要“吃两人份”；严重孕吐或无法进食则提早就医。

依据：[3][17]；每周增重观察目标为温和执行建议，可由营养师调整。

08 / 每天吃什么、喝什么

女方加足，男方不跟着双倍加餐

类别	家庭执行参考	注意
主食	三餐都有；米饭、面、杂粮、土豆轮换	女方不减碳水；不靠大量粗粮把胃口占满
蛋白质	每日一个蛋，午晚餐轮换鱼虾、瘦肉、禽肉、豆腐	每餐可用自己掌心大小的一份作起点；不是精确处方
奶类	每日约 300-500 毫升牛奶／相当量酸奶，分次	女方可用全脂；乳糖不耐受可选无乳糖奶或合适替代品
蔬菜与水果	蔬菜约 300-500 克，水果约 200-350 克；按食欲分配	不要拿蔬菜、水果或果汁代替主食和肉蛋奶
鱼类	每周约 2-3 次，合计约 225-340 克可食部分，选择低汞品种	三文鱼、沙丁鱼、鳕鱼、虾等轮换；避免鲨鱼、剑鱼等高汞大型鱼
油、坚果与调味	正常烹调油；少量无盐坚果；家庭正常使用碘盐	女方不必吃“水煮减脂餐”；不用海带粉、碘片自行补碘

山姆饮料与气泡水怎么选

不含酒精和咖啡因的普通气泡水可以喝，重点看是否挤占正餐、是否高糖、是否频繁伤牙。白水和奶作为主要饮品；甜饮不用于增重。标签写“0 蔗糖”仍可能含其他糖，要看营养表。胃胀时减少气泡水。

如果以后喝咖啡、浓茶或能量饮料，孕期咖啡因总量通常控制在每天 200 毫克以内；你目前基本不喝，不需要为了备孕开始喝。果汁不等同完整水果；酸甜饮尽量随餐，不长时间小口啜饮，喝后清水漱口。

正式尝试后，按可能已怀孕的食品卫生标准

- ☐ 鱼、肉、海鲜和蛋充分加热；避免生鱼片、生腌和未熟肉蛋。
- ☐ 选巴氏杀菌／灭菌奶；生熟刀板分开，剩菜冷藏并充分复热。
- ☐ 水果蔬菜洗净；不自行长期高频吃动物肝脏补营养，避免额外视黄醇补充。
- ☐ 女方从开始尝试起不饮酒；男方尽量少喝或不喝，尤其避免醉酒和一次大量饮酒。

依据：[13][15][18][19][20]；食物数量为可调整参考，不必每天称重打卡。

09 / 一周菜单与采购示例

普通家庭饭菜就能完成，不需要“助孕食谱”

以下按女方需要稳定供给、双方一起吃饭设计。每餐主食按食欲吃够；男方蔬菜和蛋白质照常吃，额外增重加餐只给女方。全周奶类分次喝，鱼肉蛋均做熟；调味正常、少油炸。

星期	早餐	午餐	晚餐
一	牛奶、鸡蛋、全麦面包	米饭、番茄牛肉、青菜	米饭、香菇鸡肉、豆腐
二	酸奶、燕麦、鸡蛋	米饭、清蒸鳕鱼、炒西兰花	鸡肉杂蔬面、豆干
三	牛奶、馒头、鸡蛋	米饭、瘦猪肉、菌菇青菜	米饭、番茄豆腐、虾仁
四	无乳糖奶或普通奶、面包、蛋	米饭、煎熟三文鱼、时蔬	土豆炖牛肉配适量米饭
五	酸奶、燕麦、鸡蛋	米饭、鸡腿肉、豆腐青菜	瘦肉青菜汤面、玉米
六	牛奶、包子、鸡蛋	米饭、蒸鱼、南瓜、青菜	米饭、香菇肉片、豆干
日	牛奶、面包、鸡蛋	杂粮饭、鸡肉、西兰花	家常肉菜饭或面，补足本周少吃的类别

女方加餐轮换，每天选一组并按胃口调整

组合	搭配方式
A	牛奶 250 毫升 + 一片面包 + 少量坚果，分两次也可以
B	原味酸奶一杯 + 香蕉一根 + 少量坚果，按包装热量调整
C	牛奶一杯 + 鸡蛋一个 + 小馒头／面包，正餐不减少
D	正常三餐外加小份鸡肉／豆腐面，适合不喜欢奶甜点时

一次采购的类别清单

主食：米、面、燕麦、面包、薯类。蛋白质：鸡蛋、鸡肉、瘦肉、豆腐及 2-3 次鱼虾。奶：看保质期按需买，确保女方每天可分配 300-500 毫升左右。蔬果：深浅色蔬菜轮换、两三种水果。加餐：原味坚果、小份酸奶和面包。

不用追求特殊食物

没有某种黑豆、榴莲、燕窝、红糖水或“暖宫餐”能保证排卵、着床或宝宝性别。若吃了某样不舒服，可换同类别普通食物；菜单的目的只是让三餐更容易坚持。

菜单为执行示例；营养原则见第 07-08 节，食量按实际胃口和体重趋势调整。

10 / 两个人的运动、睡眠与男方准备

从久坐和零运动开始，不突然上强度

阶段	共同运动安排	女方／男方分别注意
第 1 周	每周 5 天，饭后走 10-15 分钟；久坐每 45-60 分钟起身 3-5 分钟	女方补足进食，散步不以燃脂为目标；男方工作间隙主动走动
第 2 周	逐步到每次 20 分钟；每周 2 次轻力量，各 10-15 分钟	可做椅子坐站、靠墙俯卧撑、弹力带划船；动作轻松、不憋气
第 3-4 周起	适应后争取每周约 150 分钟中等强度活动 + 2 次力量练习	能说话、略喘即可；女方如体重下降、很累，先调整饮食和运动量
验孕阳性后	无禁忌时通常可继续适量活动；首次门诊核对运动范围	出血、腹痛、头晕时停止并联系医生，不靠“硬坚持”完成目标

睡眠：稳定比追求某个神奇时间更重要

男方 7:30 起床、至少 7 小时睡眠可作为基础；若想睡足 8 小时，可把入睡时间逐步提前至约 23:30。女方建立相对固定起床时间，记录几天实际睡眠，目标多数夜晚有 7-9 小时睡眠机会。没有必须在 22 点前睡才会怀孕的门槛。

男方具体做什么

- ☐ 从现在开始建立运动和饮食习惯。BMI 24.9 按中国成人常用标准略超重，可缓慢改善腰围与体重，不需突击减肥、断食或冲刺式训练。
- ☐ 目前每月三四罐啤酒的量不支持“因此已经伤精”的判断。为了共同执行可先不喝；若偶尔喝一罐，不因这一件事自动取消整个周期。
- ☐ 继续不吸烟，避免二手烟、桑拿和反复长时间高温泡浴；普通洗澡、日常穿着不需要反复焦虑。
- ☐ 不要自行使用睾酮、合成代谢类激素或所谓壮阳助孕保健品；如以后有处方，先告诉医生正在备孕。
- ☐ 若出现睾丸疼痛或肿块、勃起射精困难，及时就诊。精液检查可按意愿咨询，不需要靠猜测判断精子质量。

家庭分工建议：男方负责安排共同散步、采购和至少部分做饭；女方的任务不是独自完成所有“备孕优化”。每周一次交流即可，不每天追问是否排卵、是否有着床感觉。

依据：[2][21][22]；起身间隔、渐进周计划与睡眠安排为实用建议。

11 / 孕前门诊、疫苗与口腔

把已做过的准备接上，补真正需要补的部分

11 月安排一次有针对性的咨询

可选就近社康、辖区妇幼或医院孕前／妇科门诊。带上本手册、叶酸瓶、鱼油实物背标、9 月疫苗记录，以及能找回的五月检查结果。报告无法恢复时，如实说医生只提示补乙肝疫苗；是否补查由医生结合病史决定。

事项	重点核对	怎么处理
乙肝	九月底是一针加强还是重新开始序列？还有无后续针次?	乙肝疫苗为非活疫苗，一般不要求因此等待 3-6 个月；是否复查抗体按指征与接种门诊安排
风疹／麻腮风	查既往接种记录或原孕检中的风疹 IgG	无免疫证据时咨询是否测针对性 IgG 或补种；IgM 不用来简单替代免疫力判断
水痘	接种／感染史都不清楚	请接种门诊评估是否需抗体或补种；成人可能需两剂，按当地产品间隔
活疫苗与等待期	麻腮风、水痘不同于乙肝	国际常见建议麻腮风后 28 天、水痘每针后 1 个月避免怀孕；国内具体产品可能要求更长，服从所用说明书及接种医生较长要求
流感等	当季接种史和本地可用产品	向医生咨询适合备孕／孕期的灭活流感等疫苗；不照搬国外所有孕期接种项目

蛀牙：家族常见，不等于已知遗传病

你提到的主要是蛀牙、智齿已拔，先安排口腔检查，看有没有女方本人现存龋齿或牙龈炎。能在孕前补好蛀牙更省心；不是每个人都必须洗牙、拍片或治疗，按牙医检查决定。

早晚用含氟牙膏刷牙、每天牙线或牙间刷；减少频繁甜饮和酸饮。怀孕后有牙痛仍应就医，必要的牙科检查、局麻和治疗通常可以安排，不能因为怀孕拖延感染。告诉牙医备孕或孕周即可。

如果免疫核对会影响首次尝试

先完成有需要的接种并等足间隔，再启动正式尝试。若安排因此推后至 1 月或更晚，仍可继续自然尝试；你们已接受出生时间浮动，无需为追月龄放弃必要准备。

依据：[23][24][25]；当地接种产品与医生建议优先于本手册通用间隔。

12 / 检查做到什么程度就够了

区分孕前核对与不孕症评估

类别	目前建议
先核对原项目	向原机构尝试找回五月的血常规、传染病／乙肝、地贫及其他已做结果。项目以当时实际记录为准，不假定免费套餐全部包含
结合偏瘦决定	门诊评估饮食与体重；若有贫血线索、体重下降或相关症状，再决定铁蛋白、甲状腺等是否需要补查
广东地区的遗传筛查	核对双方是否已做地中海贫血筛查及结果；有携带、可疑小细胞性贫血或家族史时，按遗传咨询路径进一步检查
宫颈筛查	核对年龄适用的筛查史和当地安排；有出血、分泌物异常或其他症状时就诊，不为所有人额外开一套检查
暂不作为必做套装	没有相应指征时，不要求先做输卵管造影、AMH、性激素全套、免疫凝血全套、叶酸代谢基因、连续卵泡监测或反复 TORCH 全套
男方精液检查	尚未正式尝试且无症状，可先自然尝试。若希望提前了解、过去无保护性生活很多或出现相关病史，可提前咨询男科／生殖门诊

什么时候开始评估未孕

女方目前未满 35 岁、没有已知明显风险时，规律每 2-3 天一次、无避孕并让精液进入阴道，持续约 12 个月仍未孕，应双方同步评估。若实际从 2026 年 12 月底开始，则可在 2027 年底左右启动；不要把此前避孕八年机械相加。

如果 2027 年 3 月尚未怀孕，只是几个周期，不能据此诊断不孕，也不必因为没赶上目标月份马上促排或做试管。想在尝试 3-6 个月时做一次咨询是可以的，不属于必须完成的升级步骤。

这些情况可以更早就诊

周期反复短于约 25 天或长于 35 天、明显不规律或停经；痛经进行性加重／同房痛；经间出血；既往盆腔炎或生殖系统手术等新病史；男方勃起射精困难或睾丸异常。月经推迟先验孕。

到需要评估时应两人一起开始，常见内容包括男方精液、女方排卵与按病史选择的子宫／输卵管评估。一次精液异常可能需要复查；AMH 不能单独回答“能不能自然怀孕”，也不作为安心保证。

依据：[2][8][26][27]；不是检查处方，具体项目由门诊确定。

13 / 遇到不适时，先做什么

不把所有变化都归为“着床”，也不用对每个感觉验孕

需要立即急诊／拨打 120

可能怀孕时出现突发或加重的单侧下腹痛、肩尖痛、晕厥或明显头晕苍白，尤其伴阴道出血；或大量出血、剧烈腹痛。即使试纸尚未阳性，也要及时排除宫外孕等急症。

情况	行动
轻度少量出血、持续腹痛或发热	可能怀孕或已经阳性时尽快联系妇科／产科，按症状决定当天评估；不自行吃保胎药或抗生素
频繁呕吐，无法留住水或食物，尿明显减少	及时就医评估脱水与营养，不靠硬撑或保健品缓解
牙痛伴面部肿胀、发热	尽快牙科就诊；怀孕不应成为拖延感染处理的理由
原有首日轻度痛经	可以热敷、休息，记录是否变化；不痛不需吃药。若以后需要止痛且可能怀孕，先向药师或医生说明
短期感冒或需要新药	说清“正在尝试／可能怀孕”、末次月经与验孕情况；按具体药物和剂量判断，不一概停药或一概认为安全

减少误判的六个提醒

- ☐ 乳房胀、犯困、腹部感觉或分泌物变化都不能单独确认怀孕，到合适日期用早孕试纸。
- ☐ 正常生活、走路、上厕所和同房后起身不等于把胚胎“震掉”；没有症状时无需卧床等待着床。
- ☐ 精液流出、没有抬腿或没有特定姿势，不意味着这次无效。
- ☐ 排卵试纸阳性不是早孕阳性，早孕线淡也不能据此诊断“黄体不足”。
- ☐ 偶尔晚睡、男方偶尔一罐啤酒或忘一次叶酸，不自动等于胚胎异常；记录具体暴露，再按需要咨询。
- ☐ 不使用偏方、排毒产品或“调酸碱生男生女”方案；不自行服促排卵药、激素或保胎药。

若出现接种等待期内意外怀孕、已吃不合适产品等情况，保留具体产品、日期、剂量，与产科或药师个体化评估；不是单凭一次暴露就决定终止妊娠。

依据：[5][11][24][25]；症状分级用于帮助及时求医，不能据此自行排除疾病。

14 / 可打印的记录页

只记录会帮助下一步决策的信息

每个周期填一行

实际月经首日	持续天数／明显变化	LH 首阳 可不填	验孕日期／结果
____ / ____ / ____	_____	_____	_____
____ / ____ / ____	_____	_____	_____
____ / ____ / ____	_____	_____	_____
____ / ____ / ____	_____	_____	_____
____ / ____ / ____	_____	_____	_____

首日定义：正常月经出血第一天；点滴另记。周期长度 = 相邻两次首日相差的天数。只需大致知道是否维持规律同房，不要求详细记录性生活。

女方体重与饮食，每周一次

周／日期	体重 kg	多数天三餐 + 加餐	需要调整的地方
第 1 周 _____	_____	是 / 否	_____
第 2 周 _____	_____	是 / 否	_____
第 3 周 _____	_____	是 / 否	_____
第 4 周 _____	_____	是 / 否	_____
第 5 周 _____	_____	是 / 否	_____
第 6 周 _____	_____	是 / 否	_____

开始正式尝试前确认

☐ 叶酸已续领，每片 0.4 毫克；新复合维生素没有重复叠加。

☐ 当前鱼油已暂停或已由医生／药师确认合适的替代方案。

☐ 风疹／水痘免疫已咨询；如补种活疫苗，等待期已满足。

☐ 口腔检查已安排；有需要的蛀牙治疗已与牙医讨论。

☐ 双方同意开始日期，接受几个周期未孕和出生月份浮动。

本周期第 1 天：_____ 正式开始日期：_____

按实际周期重算第 10 天：_____ 第 22 天：_____

下次预计月经日期（只作提醒）：_____

15 / 带去社康的一页摘要

可直接给医生看，避免重复讲述

内容	摘要
生育计划	希望 2027 年 9 月中旬至 11 月出生，可接受偏差；计划 2026 年 12 月中下旬起的周期开始自然尝试；未孕则继续
女方	现 27 岁；160 厘米、44 公斤，长期稳定，BMI 17.2；无已知慢病／妊娠史／生殖系统手术史；目前未上班
月经	回忆记录 4/15、5/15、6/15、7/17、8/15、9/15、10/18；后两次首日准确；间隔约 29-33 天；经期约 5 天，首日量较多、疼痛可耐受且未加重，不服止痛药
男方	现 26 岁；170 厘米、72 公斤，BMI 24.9；无已知生殖系统疾病或妊娠经历；尚未做精液检查
既往防护	约 8 年使用避孕套及体外射精，未正式规律尝试怀孕；需按实际无保护性生活暴露进一步判断
已有孕检	2026 年 5 月免费孕检，报告已删除；明确询问医生后只提示女方补一针乙肝疫苗，已于 9 月底接种
补充剂	女方 8 月中旬起每日叶酸 0.4 毫克；此前鱼油每日一粒，标签 EPA475／DHA190 毫克，降血脂用途，拟暂停；此前吃过维生素 C，剂量不详
生活与家族	不吸烟、无已知职业有害暴露；无运动、较久坐；女方长期偏瘦、饿了就吃。家族“牙不好”指蛀牙，智齿已拔；无其他已知遗传病自述
免疫不明	女方风疹／水痘接种或感染史不清；原结果是否包含相应 IgG 及双方地贫筛查，需核对

请医生帮助确认的四件事

① 偏瘦是否只需膳食干预，是否有必要补查营养或其他项目?
② 原孕检能否调取，双方地贫结果与女方免疫证据是否足够?
③ 乙肝是否还有针次／复查需要，若需其他疫苗何时可开始尝试?
④ 当前鱼油是否应停用，膳食不足时孕期 DHA 及其他营养素如何选择?

计划更新条件

如果实际月经显著变化、出现新病史／新药、完成活疫苗接种，或验孕阳性，按相应页面更新。五月检查“未提示异常”按自述记录；本手册没有替代病历确认的作用。

参考来源 / 1

官方公共卫生机构、专业学会与本地服务资料

下列来源用于支持健康原则；月份、菜单、周计划和记录表是结合你们情况编排的执行建议，不是某份指南的逐条处方。查阅日期：2026 年 11 月 6 日。

[1] 国家卫生健康委：体重管理指导原则（2024 年版） ↗
中国成人 BMI 分界与体重管理背景。

[2] ASRM：Fertility evaluation of infertile women（2026） ↗
未孕评估时点、提前评估指征、双方同步与选择性检查。

[3] HSE：Healthy weight when trying to get pregnant ↗
低体重评估与渐进营养管理。

[4] NHS：Pregnancy due date calculator ↗
预产期与实际分娩时间的区别。

[5] ASRM：Optimizing natural fertility（2022） ↗
易孕期、日历局限、同房频率与无需特定体位。

[6] NHS：Trying to get pregnant ↗
每 2-3 天同房、备孕生活方式。

[7] 国家卫生健康委：出生缺陷预防核心信息 ↗
孕前开始每日 0.4 毫克叶酸，至少持续至孕早期结束。

[8] NICE NG257：Investigation of fertility problems ↗
规律周期与有指征的排卵／生育检查。

[9] MedlinePlus：Ovulation home test ↗
家用 LH 试纸的操作与解释限度。

参考来源 / 2

官方公共卫生机构、专业学会与本地服务资料

下列来源用于支持健康原则；月份、菜单、周计划和记录表是结合你们情况编排的执行建议，不是某份指南的逐条处方。查阅日期：2026 年 11 月 6 日。

[10] NHS：Doing a pregnancy test ↗
验孕时间、阴性复测及同房后 21 天规则。

[11] NHS：Ectopic pregnancy - Symptoms ↗
腹痛、肩尖痛、晕厥等宫外孕警示症状。

[12] 深圳市医保局：生育保险产前检查范围 ↗
13 周前建册等本地衔接信息；并非完整临床产检指南。

[13] NHS：Pregnancy vitamins and supplements ↗
叶酸、避免视黄醇／鱼肝油及补充剂核对。

[14] 市场监管总局等：2020 年第 54 号公告及鱼油目录附件 ↗
鱼油保健食品原料目录与不适宜人群；不代表已核实这瓶完整背标。

[15] FDA／EPA：Advice about Eating Fish ↗
备孕／孕期低汞鱼选择与每周份量。

[16] 福州市卫健委：叶酸、铁剂与 DHA 科普 ↗
膳食不足时讨论孕期 DHA 每日约 200 毫克补充。

[17] NHS：Healthy ways to gain weight ↗
健康渐进增重及额外约 300-500 千卡的起始方法。

[18] 国家卫生健康委：2025 年 8 月 6 日新闻发布会 ↗
孕期饮食类别、奶类及适量运动的背景建议。

参考来源 / 3

官方公共卫生机构、专业学会与本地服务资料

下列来源用于支持健康原则；月份、菜单、周计划和记录表是结合你们情况编排的执行建议，不是某份指南的逐条处方。查阅日期：2026 年 11 月 6 日。

[19] CDC：Safer Food Choices for Pregnant Women ↗
生熟食品、奶制品及食品卫生。

[20] NHS：Foods to avoid in pregnancy ↗
酒精、咖啡因与孕期食物注意事项。

[21] WHO：Physical activity ↗
成人每周运动及力量活动目标。

[22] NICE NG257：Initial advice on delays in conception ↗
男性酒精与同房等备孕咨询背景。

[23] CDC：Hepatitis B Vaccine ↗
乙肝疫苗与妊娠安全背景。

[24] CDC：Guidelines for Vaccinating Pregnant Women ↗
麻腮风／水痘等活疫苗与避免妊娠间隔。

[25] 美国牙医协会 ADA：Pregnancy ↗
孕期必要牙科诊治与预防护理。

[26] 深圳市卫健委：孕前检查项目说明 ↗
本地免费孕检与地贫筛查背景；页面较早，具体以实际记录为准。

[27] NHS：Diagnosis of infertility ↗
规律无保护性生活与进一步就诊的一般解释。

适用范围与待核实事项

不保证受孕或出生日期。鱼油背标、双方完整孕检结果、风疹／水痘免疫证据仍未核实；这些已写入具体处理路径，不妨碍你们先执行叶酸、规律饮食、活动与时间规划。